

TEMA 2.6 • GINECOLOGÍA

Patología Maligna del Útero (Endometrio)

PERFIL EUNACOM 2.01.1.070

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Maligna del Útero (Endometrio)

Fisiopatología

Exceso de estrógenos sin oposición de progesterona → estímulo de proliferación endometrial → hiperplasia → cáncer.

Factores de Riesgo — Mnemotecnia HONDA

TABLA 2.6.1: LETRA VS FACTOR DE RIESGO	
LETRA	FACTOR DE RIESGO
H	Hipertensión arterial
O	Obesidad
N	Nuliparidad
D	Diabetes mellitus tipo 2
A	Anovulación (incluye SOP — sin cuerpo lúteo → sin progesterona)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Caso típico EUNACOM: Mujer obesa, diabética, hipertensa, nuligesta con metrorragia → sospechar cáncer de endometrio.

Diagnóstico

Clínica: Metrorragia (sangrado fuera del ciclo) + útero aumentado.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Diferencial clave: - Útero grande **nodular** + hipermenorrea = **Mioma** - Útero grande **liso** + hipermenorrea + dismenorrea = **Adenomiosis** - Útero grande + **metrorragia** (+ factores HONDA) = **Cáncer de endometrio**

- **Estudio:**
- **Ecografía transvaginal** → endometrio engrosado o irregular
- **Biopsia de endometrio (BEM)** — mecanismo Pipelle → confirma diagnóstico y determina tipo histológico → orienta tratamiento

Pronóstico: Determinado por la **invasión transmural** (profundidad de invasión miometrial).

Hiperplasia Endometrial

Tipos y Tratamiento

TABLA 2.6.2: TIPO VS RIESGO DE MALIGNIZACIÓN		
TIPO	RIESGO DE MALIGNIZACIÓN	TRATAMIENTO
Simple (sin atípia)	Bajo	Progestágenos orales (ciclado) O DIU medicado (Mirena) con levonorgestrel local
Atípica o compleja	Alto	Histerectomía

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Hiperplasia endometrial atípica o compleja = Histerectomía. Se pregunta en EUNACOM.
Excepción: si la paciente rechaza la cirugía por deseos de fertilidad → intentar progestágenos + curetaje (no es la conducta estándar).

Cáncer de Endometrio

Tratamiento: **Histerectomía** (cirugía principal) + quimioterapia y/o radioterapia adyuvante según estadio.

Resumen Diferencial Patología Uterina

TABLA 2.6.3: PATOLOGÍA VS SANGRADO				
PATOLOGÍA	SANGRADO	DOLOR	ÚTERO	CONDUCTA
Mioma submucoso	Hipermenorrea	No	Nodular	Miomectom histerectom
Adenomiosis	Hipermenorrea	Dismenorrea	Liso, aumentado	Histerectom
Pólipo endometrial	Hipermenorrea	No	Normal	Polipectomí
Hiperplasia simple	Metrorragia	No	Normal/aumentado	Progestáge / Mirena
Hiperplasia atípica	Metrorragia	No	Normal/aumentado	Histerectom

| Cáncer endometrio | **Metrorragia** | No | **Aumentado** | Histerectomía + QT/RT |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Patología Maligna del Útero (Endometrio), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Patología Maligna del Útero (Endometrio). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Fisiopatología
- Factores de Riesgo — Mnemotecnia ****HONDA****
- Diagnóstico
- Hiperplasia Endometrial
- Tipos y Tratamiento
- Cáncer de Endometrio
- Exceso de estrógenos sin oposición de progesterona

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA MALIGNA DEL ÚTERO (ENDOMETRIO))

PREGUNTA 1

Respecto a Patología Maligna del Útero (Endometrio), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A) El diagnóstico de Patología Maligna del Útero (Endometrio) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Patología Maligna del Útero (Endometrio) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Patología Maligna del Útero (Endometrio) requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Patología Maligna del Útero (Endometrio) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Patología Maligna del Útero (Endometrio) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Patología Maligna del Útero (Endometrio)?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Patología Maligna del Útero (Endometrio). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PATOLOGÍA MALIGNA DEL ÚTERO (ENDOMETRIO)

Exceso de estrógenos sin oposición de progesterona → estímulo de proliferación endometrial → hiperplasia → cáncer. ::tip Caso típico EUNACOM: Mujer obesa, diabética, hipertensa, nuligesta con metrorragia → sospechar cáncer de endometrio. ::: Estudio: 1. Ecografía transvaginal → endometrio engrosado o irregular 2. Biopsia de endometrio (BEM) — mecanismo Pipelle → confirma diagnóstico y determina tipo histológico → orienta tratamiento